

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PASURUAN
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)

Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 04/12/2025 di Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **SULISTIJO NISITA WIRJAWAN** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: **KEP/207/092024** tentang **Mutasi Pejabat** dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang **Pasuruan** yang berkedudukan di **Jl. Ir. H. Juanda Nomor 77, Bugul Lor, Pasuruan**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II (NAMA RUMAH SAKIT)** : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10

(Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang. Dengan Izin Operasional Rumah Sakit **No 81201150810004** tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh **Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep** sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit **Rumah Sakit Swasta** yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pemberian pelayanan kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di **PIHAK KEDUA** bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan dugaan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif.
7. *Trauma Center* BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
8. Eligibilitas adalah kelayakan peserta untuk mendapatkan manfaat Pelayanan Kesehatan akibat Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
9. Surat Kelayakan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat program JKK.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran administrasi klaim dan Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PLKK.
11. Aplikasi PLKK selanjutnya disebut Aplikasi e-PLKK adalah sistem informasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan PLKK dalam menjalankan operasionalnya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta dengan kondisi antara lain:
 - a. mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - b. mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta yang mengalami:
 1. Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 2. dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK;
- b. tarif Pelayanan Kesehatan;
- c. tata cara pengajuan dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- d. kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan berdasarkan prosedur Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Peserta.
- (2) Prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dibayarkan sesuai Tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yaitu **Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur**.
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK menggunakan tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bulan berjalan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pengajuan tagihan dari **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tagihan biaya pelayanan kesehatan:
 - a. yang semula disimpulkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK dan telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan namun ditetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh pengawas ketenagakerjaan atau Menteri Ketenagakerjaan serta telah dilakukan proses pengembalian pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PLKK kepada BPJS Kesehatan; atau
 - b. yang semula disimpulkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK namun ditetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh pengawas ketenagakerjaan atau Menteri Ketenagakerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

- sejak pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal dokumen tidak lengkap, **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
 - (6) Dalam hal dokumen lengkap, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi kelengkapan dokumen kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (7) **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan hasil verifikasi;
 - b. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai dan/atau tidak benar maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan;
 - c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kembali oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Bentuk dokumen penyampaian informasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (9) Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
 - (10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan pengajuan tagihan, **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian nilai kuitansi sesuai dengan nilai pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (11) Tata cara pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan secara rinci diatur dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KADALUARSA KLAIM

- (1) Masa kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pelayanan Kesehatan selesai diberikan.
- (2) Masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pengajuan tagihan sebagai berikut:

- a. biaya Pelayanan Kesehatan yang belum ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. biaya Pelayanan Kesehatan yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, namun dokumen belum lengkap dan tidak ditagihkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. biaya Pelayanan Kesehatan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** dan tidak ditagihkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 DATA

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penanganan kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK atau dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK, menyampaikan data kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa:
 - a. data dokter, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) NIK;
 - 3) nomor handphone;
 - 4) Surat Izin Praktik;
 - 5) jadwal praktik pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - 6) detail kompetensi dokter;
 - b. sarana dan prasarana pelayanan medis **PIHAK KEDUA**;
 - c. tarif tindakan; dan
 - d. harga nett apotek obat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** melalui daring dan/atau luring, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut melalui surat yang disampaikan secara daring dan/atau luring.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - 1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - 2) Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
 - b. mendapatkan data dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK berhak

- mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas **2**;
 - f. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK mendapatkan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan kesimpulan dari dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - i. melakukan kredensialing kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - j. auditor **PIHAK PERTAMA** atau pihak eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan audit terhadap biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di **PIHAK PERTAMA**;
 - k. melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 - l. melakukan Verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - m. mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari **PIHAK KEDUA** yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - n. mendapatkan kepastian pembiayaan dari **PIHAK KEDUA** untuk penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja;
 - o. menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - p. memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - q. menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. membuat kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - e. melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan berkas dokumen dimaksud;
 - f. melakukan Verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
 - g. melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar dibuktikan dengan hasil verifikasi; dan
 - h. membayarkan kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari **PIHAK PERTAMA** bagi petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. mendapatkan kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - e. melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - f. menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan benar berdasarkan Verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. meminta penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** perihal hasil Verifikasi dan pembayaran;
 - h. menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - j. mendapatkan informasi hasil Verifikasi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - 1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan

- 2) Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK,
- b. menyampaikan data kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. menyampaikan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2 bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 - f. menyediakan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - h. menyediakan data dan informasi untuk **PIHAK PERTAMA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyediakan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - j. menyampaikan kesimpulan dari dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - k. mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - l. menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** perihal Kecelakaan Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - m. menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - n. memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian *user* **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

- o. melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait **PIHAK PERTAMA** di tempat strategis;
- p. menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja pada **PIHAK KEDUA**;
- q. mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**;
- r. menyediakan sistem antrian, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU yang dapat diakses oleh Peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
- s. menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska klaim, **PIHAK KEDUA** mengizinkan untuk melihat rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- t. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN DUGAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menyampaikan pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK yang dialami oleh Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
 - b. kronologi kejadian, termasuk tempat, sumber penyebab, tanggal dan jam kejadian Kecelakaan Kerja; dan
 - c. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
- (3) Pemberitahuan dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
 - b. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. masa kerja dan masa kerja pada pekerjaan terakhir;
 - e. sumber pajanan; dan
 - f. diagnosis klinis.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2026** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
 - a. telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** pemberi informasi;
 - b. informasi dan data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan
 - d. berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN *MONEY LAUNDERING*

- (1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
 - c. menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15 SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terlambat melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan;
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. petugas **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang merusak citra **PIHAK PERTAMA**;
 - e. memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan; dan/atau
 - f. **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan kesimpulan dugaan PAK kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf j;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dalam hal **PIHAK KEDUA**:
 - 1) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**; atau
 - 2) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. apabila surat peringatan pertama telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA**:
 - 1) tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan untuk pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan kedua; atau
 - 2) tidak menyampaikan kesimpulan dugaan PAK sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa klinis dugaan PAK telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka seluruh biaya Pelayanan Kesehatan atas dugaan PAK Peserta menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dan **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kecurangan yang merugikan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan teguran dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan pertama kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran yang telah ditentukan;
 - b. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** masih belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan kedua;
 - c. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran tagihan, maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pemberitahuan penghentian sementara pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** kembali memberikan Pelayanan Kesehatan setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 16

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif dan operasional sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. kualitas pelayanan.

PASAL 17

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah berdasarkan surat pemberitahuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pihak yang berwenang yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan atau tambahan (adendum) dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

PASAL 20

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disetujui Pihak lainnya; atau
 - c. pengakhiran sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Terhadap pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki;
 - b. **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama wajib memberikan jawaban terhadap pengajuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tertulis diterima; dan
 - c. dalam hal **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, permintaan pengakhiran dianggap disetujui.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan atas kehendak **PIHAK PERTAMA** dalam hal:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** namun tidak ada tanggapan dan tidak ada perbaikan;
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan kecurangan;
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan malpraktik;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar kredensialing yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar pernyataan anti korupsi, penyuapan, dan *money laundering*; dan/atau
 - f. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 21

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

**PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN**

**Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT**

**SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG**

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor **PIHAK PERTAMA**)
Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

1. Pelayanan medis kepada peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan dengan **Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur**.
2. Pelayanan medis kepada peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang perawatan kelas **2**, untuk Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di ruang perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan kelas yang seharusnya tersedia kembali. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih tinggi ditagihkan berdasarkan tarif kelas perawatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan selisih biaya yang timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, Peserta, keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di ruang perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan kelas yang seharusnya tersedia kembali. Selisih biaya yang timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, Peserta, keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Dalam hal kelas ruang perawatan sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) belum tersedia lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Peserta di rawat inap maka Peserta diberikan pilihan:
 - a. dirawat 1 (satu) kelas lebih rendah; atau
 - a. dirujuk ke PLKK lain.

6. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih rendah sesuai dengan angka 5 (lima) huruf a ditagihkan sesuai ruang kelas perawatan yang digunakan oleh Peserta.
7. Dalam hal Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian menginginkan kelas perawatan lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan maka Peserta/keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian harus menandatangani surat pernyataan dari Rumah Sakit dan selisih biaya menjadi tanggung jawab Peserta/keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Lama hari rawat inap dihitung dari selisih antara tanggal pulang/tanggal keluar rumah sakit (kondisi hidup atau meninggal dunia) dengan tanggal masuk rumah sakit.
9. Dalam hal Peserta diberikan Pelayanan Kesehatan di ruang rawat inap yang masuk dan keluar pada hari yang sama maka dihitung 1 (satu) hari.

II. ALUR PELAYANAN

PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program JKK dan/atau Program JKN yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK, dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK melalui prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Pasien datang berobat pada **PIHAK KEDUA** dan Petugas **PIHAK KEDUA** melakukan identifikasi serta pemeriksaan untuk menentukan apakah Pasien memenuhi kriteria:
 - a. Kasus Kecelakaan Kerja;
 - b. PAK;
 - c. Dugaan Kecelakaan Kerja; dan
 - d. Dugaan PAK,
2. Dalam hal Pasien sebagaimana angka 1 (satu) memenuhi salah satu kriteria, maka Petugas **PIHAK KEDUA** meneliti Eligibilitas:
 - a. Bagi Peserta PU dan BPU melalui Aplikasi e-PLKK berdasarkan NIK atau Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>) dan/atau kemudian menghubungi petugas **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan konfirmasi apabila diperlukan; atau
 - b. Bagi Peserta Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia melalui konfirmasi kepada petugas **PIHAK PERTAMA**,
3. Dalam hal Peserta memenuhi kriteria sebagaimana pada angka 1 (satu) huruf a, huruf b, atau huruf c dan eligibilitas Kepesertaan, maka:
 - a. untuk Peserta PU dan BPU, petugas **PIHAK KEDUA** mengisi uraian Kecelakaan Kerja/PAK/dugaan KK di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/form/tahap1.bpjs>) sebagai pemberitahuan Kecelakaan Kerja/PAK/dugaan KK kepada Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga melalui daring/luring;
 - b. untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia, petugas **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada Peserta/Pemberi

- Kerja/Perusahaan Jasa Konstruksi agar menyampaikan laporan tahap 1 KK/PAK; atau
- c. untuk Pekerja Migran Indonesia dikecualikan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d,
 4. Dalam hal Peserta memenuhi kriteria sebagaimana pada angka 1 (satu) huruf d dan eligibilitas Kepesertaan, maka petugas **PIHAK KEDUA** mengarahkan Peserta diperiksa oleh Dokter **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Diagnosa Klinis dugaan PAK melalui formulir diagnosa klinis PAK;
 5. Dalam hal dokter **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyatakan bahwa Peserta memperoleh diagnosa klinis dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka:
 1. untuk Peserta PU dan BPU, petugas **PIHAK KEDUA** mengisi uraian dugaan PAK di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*:<https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/form/tahap1.bpjs>) dan mengupload dokumen formulir diagnosa klinis PAK yang diisi oleh dokter **PIHAK KEDUA** sebagai pemberitahuan dugaan PAK kepada Peserta, Pemberi Kerja, Keluarga dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian melalui daring/luring; atau
 2. untuk Peserta Jasa Konstruksi, petugas **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada Peserta/Pemberi Kerja/Perusahaan Jasa Konstruksi agar menyampaikan laporan tahap 1 KK/PAK,
 - b. menyatakan bahwa Peserta tidak memperoleh diagnosa klinis dugaan PAK, maka:
 1. untuk Peserta PU, BPU, Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia yang memiliki rujukan dari fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama melalui mekanisme JKN, maka Peserta akan dilayani melalui penjaminan Program JKN; atau
 2. untuk Peserta PU, BPU, Jasa Konstruksi yang tidak memiliki rujukan dan bukan kasus gawat darurat, Peserta dapat menggunakan asuransi lain atau pembiayaan lainnya diluar mekanisme yang ada di **PARA PIHAK** dan Peserta tidak dijamin dalam koordinasi penjaminan dugaan PAK,
 6. Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga menindaklanjuti pemberitahuan dari petugas **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan laporan tahap I;
 7. Dalam hal penyampaian laporan tahap I dilakukan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga melalui **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Untuk Peserta Penerima Upah, Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan tahap I kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** dengan sarana:
 - a. bagi Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian mengisi e-formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau e-formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; atau

- b. bagi Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian bukan merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I,
 - 7.2. Untuk Peserta Bukan Penerima Upah, Peserta/pihak keluarga mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; dan
 - 7.3. Untuk Peserta Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia maka, Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian/Perusahaan Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I,
8. **PIHAK KEDUA** menyampaikan pengajuan SKP kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan laporan tahap I beserta dokumen pendukung;
9. **PIHAK KEDUA** memastikan Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian/Peserta/keluarga/Perusahaan Jasa Konstruksi/Pekerja Migran Indonesia/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengisi dan menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pengobatan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi/pemeriksaan terhadap permohonan pengajuan SKP dari **PIHAK KEDUA** dan menerbitkan SKP paling lambat 2 (dua) hari kerja melalui website e-PLKK (<https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/>);
11. **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Peserta memerlukan tindakan operatif/pemeriksaan khusus maka petugas **PIHAK KEDUA** wajib melakukan konfirmasi kepada Petugas **PIHAK PERTAMA**;
12. Dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat Peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus Penyakit Akibat Kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai dengan status kondisi akhir sembuh, cacat, atau meninggal dunia;
13. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jasa pengangkutan berupa pelayanan ambulans untuk menjemput dan/atau mengantar Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK di lokasi kerja ke rumah sakit dan /atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja/PAK, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan
14. Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan tarif kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

III. PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

1. Pemberian resep obat-obatan oleh dokter yang memeriksa atau dokter yang menangani di **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program JKK mengutamakan obat Generik dan Formularium Nasional.

2. Harga obat dan alat kesehatan menggunakan patokan Harga Netto Apotik ditambah PPN dan biaya pelayanan kefarmasian 30% dari harga tersebut.
3. Harga Netto Apotik sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengacu pada tarif yang disepakati saat ditandatanganinya Berita Acara Negosiasi Tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Untuk harga obat dan alat kesehatan lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan patokan harga netto ditambah PPN dengan biaya pelayanan kefarmasian 20%.

IV. RUJUKAN

Dalam hal Peserta memerlukan penanganan di PLKK yang lebih lengkap dan/atau alasan lain dengan persetujuan dokter yang merawat, **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta ke PLKK lainnya dengan melaksanakan prosedur sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan persetujuan untuk dirujuk ke PLKK lain dari dokter yang merawat;
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penginputan e-formulir rujukan dalam Aplikasi e-PLKK dan memilih PLKK tujuan rujukan bagi Peserta PU dan BPU. Bagi Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia mengisi dan mengirimkan formulir rujukan secara manual kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** menginformasikan adanya rujukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia;
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan e-formulir/formulir rujukan dan berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PLKK rujukan;
5. Dalam hal Peserta layak dirujuk ke PLKK lain, **PIHAK PERTAMA** melakukan persetujuan rujukan dan mengirimkan pemberitahuan ke PLKK tujuan rujukan; dan
6. Dalam hal PLKK rujukan menerima Peserta, PLKK penerima rujukan memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis Peserta.

V. KATEGORI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta program JKK meliputi:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan Perawatan lanjutan;
3. Rawat inap;
4. Penunjang diagnostik
5. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan kerja dan PAK;
6. Perawatan intensif;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Pelayanan darah;
12. Rehabilitasi medik;

13. Perawatan dirumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus PAK.

VI. KOMORBIDITAS DAN KOMPLIKASI

1. Komorbiditas dan komplikasi yang dapat ditanggung merupakan komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK;
2. Komorbiditas/penyakit penyerta yang diderita oleh Peserta sebelum terjadi Kecelakaan Kerja atau PAK dapat ditanggung **PIHAK PERTAMA** saat Peserta menjalani perawatan pertama di **PIHAK KEDUA**;
3. Peserta yang mengalami komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sejak Peserta menjalani perawatan dan pengobatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan pada saat rawat inap dan rawat jalan akibat kecelakaan kerja atau PAK sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia; dan
4. Komorbiditas dan komplikasi dijamin setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

VII. PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI

1. Penggantian biaya administrasi rawat inap dan rawat jalan untuk biaya Pelayanan Kesehatan di **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur** dengan ketentuan:
 - a. maksimal 3% dari keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Biaya pendaftaran untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap mengacu pada tarif Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur.

VIII. HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG

1. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:
 - a. penyakit akibat hubungan kerja (*work related diseases*) yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
 - b. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
 - c. Kecelakaan Kerja dan PAK yang diakibatkan dari tindakan yang melanggar hukum;
 - d. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis;
 - e. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;
 - f. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - g. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
 - h. Pelayanan Kesehatan rujukan ke luar negeri; atau

- i. kategori lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Peserta yang telah dijamin untuk dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK dan telah mendapatkan Kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka ketentuan hal yang tidak ditanggung diluar dari yang telah disebutkan pada angka 1 (satu) mengikuti ketentuan pada program JKN.

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN

Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT

SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- I. Tarif pelayanan/perawatan sesuai berita acara negosiasi yaitu
1. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	Tindakan Non Operatif	Asuhan Pasien (Rp)
1	Asuhan Pasien	200.000/hari
2	Pasang Infus	
3	Lepas Infus	
4	Konsultasi Gizi	
5	Administrasi RI	3% dari total tagihan RI
6	Administrasi RJ	50.000
7	ID Card	5.000

Biaya administrasi rawat inap maksimal 3% dari keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap periode rawat inap.

2. TARIF LAYANAN POLIKLINIK

NO	Jenis Poli	Jasa Pemeriksaan RJ (Rp)
1	Poli Umum	150.000
2	IGD	65.000
3	Poli Gigi Umum	105.000
4	Poli Spesialis	149.500
5	Poli Gigi Spesialis	170.000

3. TARIF KAMAR RAWAT INAP

NO	Kelas Perawatan	RI (Rp)
1	VVIP	
	Viola A	962.500
	Viola B	962.500
2	VIP	
	Anggrek	742.500
3	Kelas 1	
	Bougenvile	467.500
	Jasmine	467.500
4	Kelas 2	
	Cempaka A	275.000
	Cempaka B	275.000
5	Kelas 3	
	Dahlia A	220.000

	Dahlia B	220.000
	Dahlia C	220.000
	Mawar	220.000
6	Isolasi	
	Isolasi A (covid)	1.100.000
	Isolasi B	295.000
	Isolasi T.Negatif	1.100.000
7	Perina	
	Perinatologi Level I	302.500
	Perinatologi Level II	467.500
	Perinatologi Level III / NICU	627.800
8	ICU	
	ICU	687.500

4. TARIF VISITE RAWAT INAP

NO	Kelas Perawatan	RI (Rp)
A. VISITE DOKTER SPESIALIS		
1	VVIP	260.000
2	VIP	227.500
3	I	195.000
4	II	149.500
5	III	130.000
6	ICU	687.000
7	Isolasi	337.500
8	Isolasi Covid	455.000
9	Perinatologi Level 1	130.000
10	Perinatologi Kelas 1 (lev 3)	397.000
	Perinatologi Kelas 2 (lev 3)	357.000
	Perinatologi Kelas 3 (lev 3)	326.000
B. VISITE DOKTER UMUM		
1	VVIP	130.000
2	VIP	97.500
3	I	84.500
4	II	65.000
5	III	52.000
6	Isolasi	104.000

5. LABORATORIUM

NO	Tindakan	RJ	II
A. Patologi Klinik			
1	S.G.O.T	46.041	46.041
2	S.G.P.T	46.041	46.041
3	Albumin	77.400	77.400
4	Bilirubin	72.500	72.500
5	Kolesterol Total (**)	43.500	46.041
6	Kolesterol – HDL	140.000	140.000
7	Kolesterol – LDL	79.380	79.380
8	Trigliserida (*)	46.570	46.570
9	Urea	31.000	31.000
10	Urea Clearance	54.625	57.815
11	Creatinin	46.041	46.041
12	Creatinin Clearance	62.188	65.820

13	Urid Acid (*)	46.041	46.041
14	Gula Darah Puasa (*)	46.041	46.041
15	Gula Darah 2 jam PP (**)	46.041	46.041
16	Gula Darah Sewaktu	46.041	46.041
17	HbA1c	231.250	244.755
B. Hematologi			
1	Darah Lengkap	85.995	85.995
2	Hapusan Darah	97.313	102.996
3	Gol. Darah + Rhesus	31.063	32.876
4	D-Dimer	400.625	424.021
C. Faal Hemostasis			
1	Bleeding Time	18.125	19.184
2	Clotting Time	18.125	19.184
3	PPT	74.000	78.322
4	KPPT	86.500	91.551
5	INR	99.375	105.179
D. Faal Jantung			
1	ECG	56.250	59.535
2	CKMB	111.500	117.708
3	Troponin I	107.250	113.513
E. Elektrolit & Analisa Gas Darah			
1	Blood Gas Analisa (BGA)	300.000	300.000
2	Elektrolit	196.500	207.975
F. Imunno - Serologi			
1	Hbs Ag (Kualitatif)	77.131	77.131
2	HBS AB RPHA	71.156	75.312
3	HBS AB EIA	157.176	166.356
4	Ig G/M Anti Dengue	262.500	277.830
5	H.I.V	79.380	79.380
6	Anti HCV	360.875	381.950
7	Widal	47.250	50.009
8	Ig M Salmonela	344.375	364.486
9	Procalcitonin	803.750	850.689
10	Rhematoid Faktor	74.750	79.116
G. Endokrinologi			
1	T S H	242.250	256.398
2	Free T4	220.750	233.642
H. Mikrobiologi			
1	Preparat BTA SPS	130.250	137.857
2	Analisa Sperma	91.250	96.579
I. Narkoba			
1	Amphetamine Test	92.500	97.902
2	Methamphetamine Test	74.750	79.116
3	Cocaine Test	74.750	79.116
4	Tes Narkoba 7 parameter	175.000	193.000
J. Urine			
1	Urine Lengkap (UL)	33.500	35.457
2	Pregnoction Plano Test	33.500	35.457
K. Transudat / Eksudat			
1	Analisa Cairan Pleura	307.750	325.722
2	Analisa Cairan Acites	307.750	325.722
L. Feses			
1	Faeces Lengkap (FL)	32.750	34.663

M. Kimia Darah			
1	Alkali Fosfatase	74.800	79.168
2	Gamma GT	39.531	41.840
N. Hematologi			
1	Feritin	352.000	372.557
2	ANA Test	453.750	480.249
3	Serum Ion	79.063	83.679
4	TIBC	79.063	83.679
5	Hb Elektroforesis	649.825	687.775
6	Retikulosit	82.500	87.318
7	Coomb Test Direck Indireck	575.575	609.188
O. Faal Hemostasis			
1	Fibrinogen	213.125	225.571
P. Faal Jantung			
1	CK/CPK	124.523	137.287
Q. Imunno - Serologi			
1	Hbs Ag Elisa	170.500	180.457
2	Anti Hbs Elisa	261.525	276.798
3	IgM HAV	195.250	206.652
4	NS One Dengue	411.125	435.134
5	TB DOT	226.875	240.125
6	VDRL	79.063	83.679
7	TPHA	102.781	108.783
8	IgG Toxoplasma	249.048	263.593
9	IgM Toxoplasma	249.047	263.591
10	IgG Rubella	227.057	240.317
11	IgM Rubella	272.766	288.695
12	Amylase	239.938	253.950
13	Lypase	232.238	245.800
14	ICT Malaria	411.155	435.167
15	DS DNA	403.975	427.567
16	ASTO	154.000	162.994
17	CRP	117.013	123.846
18	Interlukin 6 / IL6	452.405	478.826
R. Endokrinologi			
1	T3	226.875	240.125
S. Mikrobiologi			
1	Kultur PUS	399.300	422.619
2	Kultur Darah	767.250	812.057
3	Kultur Sputum	635.250	672.348
4	Kultur Faeces	341.550	361.497
5	Kultur Urine	541.338	572.952
6	Rectal Swab	399.300	422.619
T. Tumor Marker			
1	AFP	278.300	294.553
2	CEA	396.000	419.126
3	Beta HCG Serum	367.400	388.857
4	PSA	327.319	346.434
5	Ca-125	407.172	430.951
6	Ca-19-9	441.881	467.687
7	NSE	1.123.650	1.189.271
8	LDH	173.030	183.135
U. Feses			
1	Benzidine Test	160.806	170.197

V. Lain-Lain			
1	ACA Ig G	377.500	399.546
2	ACA Ig M	531.250	562.275
3	Acid Phospatase	158.125	167.360
4	Adhenosine Deaminase	851.800	901.546
5	Ana profile	1.617.375	1.711.830
6	Analisa Batu	242.500	256.662
7	Anti Toxoplasma	234.000	247.666
8	APO A1	239.250	253.222
9	APO B	239.250	253.222
10	Asam Laktat	502.625	531.978
11	Bence Jones	25.875	27.386
12	Bile Acid	230.000	243.432
13	Cholinesterase	143.750	152.145
14	Eosinofil	43.125	45.643
15	Estradiol	337.813	357.540
16	Fruktosamin	301.875	319.504
17	FSH	265.938	281.468
18	Fosfor Anorganik	53.906	57.055
19	G-6PD	179.688	190.181
20	GO	156.250	165.375
21	GRAM	31.250	33.075
22	GTTOT	143.750	152.145
23	HBV DNA (Kualitatif)	1.831.250	1.938.195
24	IG A	265.938	281.468
25	IG A Neufropati	750.000	793.800
26	IG E	265.938	281.468
27	IG G	265.938	281.468
28	IG G/IG M Leptospirosis	672.500	711.774
29	IG G/IG M H.Pylori	230.938	244.425
30	IG G Anti HBc	265.938	281.468
31	IG G Anti HSV 1	344.813	364.950
32	IG G Anti HSV 2	344.813	364.950
33	IG G CMV	344.813	364.950
34	IGRA	2.062.500	2.182.950
35	Insulin	250.000	264.600
36	Insulin Puasa	490.090	518.711
37	Kalium	43.750	46.305
38	Kultur cairan Pleura	332.500	351.918
39	Kultur H-Phylori	940.000	994.896
40	Kultur Hasil Operasi	143.750	152.145
41	Lipase	211.125	223.454
42	Lipid Profile	143.750	152.145
43	Lipid Total	57.500	60.858
44	Lupus Anticoagulant	5.455.534	5.774.137
45	Magnesium	53.906	57.055
46	Malaria	34.500	36.515
47	Mantoux test	93.750	99.225
48	Vitamin D	577.500	611.226
49	VVP Preparat	62.500	66.150
50	Widal Felix	122.188	129.324

6. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RJ	II
Radiodiagnostik			
Foto tanpa bahan kontras			
1	Foto Skull AP	225.000	225.000
2	Foto Skull LAT	225.000	225.000
3	Foto Waters	248.700	248.700
4	Cervical (AP/LAT/OBL)	204.900	204.900
5	shoulder clavícula (AP)	184.500	184.500
6	Thorax (AP/RLD)	156.000	156.000
7	humerus (AP/LAT)	187.500	187.500
8	antebrachii (AP/LAT)	187.500	187.500
9	elbow (AP/LAT)	187.500	187.500
10	Foto wrist (AP/LAT)	187.500	187.500
11	manus (AP/OBL)	187.500	187.500
12	Foto BNO (AP/LLD/SEMIUPRIGHT)	211.500	211.500
13	pelvis (AP)	204.900	204.900
14	femur (AP/LAT)	204.900	204.900
15	genu (AP/LAT)	204.900	204.900
16	cruris (AP/LAT)	204.900	204.900
17	ankle (AP/LAT)	204.900	204.900
18	pedis (AP/OBL)	204.900	204.900
19	Foto Colon in Loop	1.350.000	1.350.000
CT Scan Tanpa Kontras			
1	CT SCAN BRAIN	1.075.000	1.075.000
	CT SCAN BRAIN TRAUMA	1.202.965	1.202.965
2	VERTEBRATE		
	CT SCAN OCCIPITO-ATLANTO-AXIAL REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN CERVICAL REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN CERVICOTHORACIC REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN THORACIC REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN THORACOLUMBAL REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN LUMBAR REGION	2.174.957	2.174.957
	CT SCAN LUMBOSACRAL REGION	2.174.957	2.174.957
3	GENU		
	CT SCAN GENU	1.891.890	1.891.890
4	FEMUR		
	CT SCAN FEMUR	1.891.890	1.891.890
5	CRURIS		
	CT SCAN CRURIS	1.891.890	1.891.890
6	ABDOMEN		
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN	2.994.390	2.994.390
7	Thorax (CHEST)		
	CT SCAN THORAX	3.170.377	3.170.377
8	PELVIS		
	CT SCAN PELVIS	2.994.390	2.994.390
9	ANGIOGRAFI		
	CT SCAN ANGIORAFI	4.582.266	4.582.266
10	CARDIAC		
	CT SCAN CARDIAC	4.582.266	4.582.266

CT Scan Dengan Kontras			
1	CT SCAN BRAIN / KEPALA	1.675.000	1.675.000
	CT SCAN BRAIN TRAUMA	2.024.869	2.024.869
2	VERTEBRATE		
	CT SCAN OCCIPITO-ATLANTO-AXIAL REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN CERVICAL REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN CERVICOTHORACIC REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN THORACIC REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN THORACOLUMBAL REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN LUMBAR REGION	2.994.481	2.994.481
	CT SCAN LUMBOSACHRAL REGION	2.994.481	2.994.481
3	GENU		
	CT SCAN GENU	2.712.107	2.712.107
4	FEMUR		
	CT SCAN FEMUR	2.712.107	2.712.107
5	CRURIS		
	CT SCAN CRURIS	2.712.107	2.712.107
6	ABDOMEN		
	CT SCAN WHOLE ABDOMEN	3.811.907	3.811.907
7	THORAX (CHEST)		
	CT SCAN THORAX	3.987.462	3.987.462
8	PELVIS		
	CT SCAN PELVIS	3.811.907	3.811.907
9	ANGIOGRAFI		
	CT SCAN ANGIORAFI	5.395.894	5.395.894
10	CARDIAC		
	CT SCAN CARDIAC	5.395.894	5.395.894
USG			
1	USG Kepala	323.438	323.438
2	thorax	323.438	323.438
3	abdomen	265.625	265.625
4	Vaskuler	781.250	781.250
5	Urinary	359.375	359.375
6	disgetive	323.000	323.000
7	retoperitoneum	265.625	265.625
8	Uterus	390.625	390.625
9	Breast	328.125	328.125
10	Uterus Gravid	328.125	328.125
11	Heart	468.750	468.750
12	Lang	468.750	468.750
13	THYROID	359.375	359.375
14	Sceletal	323.000	323.000
15	Audiometri	312.500	312.500
16	Musculoskeletal	323.000	323.000

7. REHABILITASI MEDIS

No	Tindakan	RJ (Rp)
1	Terapi Heat	167.300
2	Diathermy Terapi	80.000
3	Elektro Terapi	177.400

4	Laser Terapi	175.600
5	Facial Massage Exercise	148.400
6	Pasive Musculoskeletal Exercise	148.400
7	Active Musculoskeletal Exercise	148.600
8	Resisted Musculoskeletal Exercise	147.900
9	Assisting Exercise	210.600
10	Stretching Exercise	80.000
11	Gait Training Exercise	148.200

8. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No	Tindakan	RJ	II
1	Aff Drain	140.000	140.000
2	Animek (per labu)	40.000	40.000
3	Close Reduction	820.000	820.000
4	Corpus Alienum	200.000	200.000
5	Doppler / Kali	10.000	10.000
6	DC Shock	220.000	220.000
7	Drip	730.000	730.000
8	Evakuasi Feces	200.000	200.000
9	Fisioterapi	170.000	170.000
10	Foto Therapie per Seri	150.000	150.000
11	Gizi	24.000	24.000
12	Gliserin	210.000	210.000
13	Hecting 1 - 5 cm	302.000	302.000
14	Hecting 16 - 30	302.000	302.000
15	Hecting 6 - 15 cm	424.000	424.000
16	Hecting Porsio	950.000	950.000
17	Incisi < 5 cm	610.000	610.000
18	Incisi > 5 cm	760.000	760.000
19	Infant Warmer	335.925	335.925
20	Infuse Pump	110.000	110.000
21	Injeksi Haemoroid	870.000	870.000
22	Injeksi IM/IV/SC/IC	25.000	25.000
23	Injeksi Intra Artikuler	332.000	332.000
24	Injeksi Keloid	220.000	220.000
25	Injeksi Kista	220.000	220.000
26	Injeksi Neuro Stimulator	290.000	290.000
27	Suntik IV	25.000	25.000
28	Suntik IM	25.000	25.000
29	Kasur Decubitus per hari	53.000	53.000
30	Kumbah Lambung	60.100	60.100
31	Konsultasi Gizi	24.000	24.000
32	Lepas Gips dr. Spesialis	143.000	143.000
33	Lepas Gips dr. Umum	143.000	143.000
34	Lepas Jahitan	200.200	200.200
35	Lepas Kondom Catheter	50.000	50.000
36	Lepas Kuku	332.000	332.000
37	Lepas NGT	30.000	30.000
38	Nebulizer Dewasa	50.200	50.200
39	Oksigen per hari	106.300	106.300
40	Oksigen per Jam	20.000	20.000
41	Pasang Catheter oleh Dokter	40.300	40.300
42	Pasang Catheter oleh Perawat	40.300	40.300
43	Pasang Deurembes	43.600	43.600

44	Pasang Gips (Oleh Dokter Umum)	280.000	280.000
45	Pasang Gips (Oleh Spesialis)	280.000	280.000
46	Pasang Infus Anak <17 Th	55.700	55.700
47	Pasang Infus Bayi <40Hr	55.700	55.700
48	Pasang Infus Dewasa	55.700	55.700
49	Pasang Infus Dengan Dokter	55.700	55.700
50	Pasang Kondom Catheter	40.300	40.300
51	Pasang Korset Umum	150.000	150.000
52	Pasang Laminaria	288.200	288.200
53	Pasang Mayo Tube	80.000	80.000
54	Pasang Pesarium	247.000	247.000
55	Pasang NGT	62.300	62.300
56	Pasang Susuk	550.000	550.000
57	Pembacaan ECG	60.100	60.100
58	Pemberian Obat Per Suppositoria	20.000	20.000
59	Proef Punksi	370.000	370.000
60	Psikoterapi Supportive	150.000	150.000
61	Punksi Asites dr. Spesialis	650.000	650.000
62	Punksi Asites dr. Umum	630.000	630.000
63	Punksi Blast	440.000	440.000
64	Rawat Jenazah	380.000	380.000
65	Rawat Luka < 5 cm	150.000	150.000
66	Rawat Luka > 16 cm	280.000	280.000
67	Rawat Luka 6 - 15 cm	210.000	210.000
68	Reduction Haemoroid	220.000	220.000
69	Remove Wire	363.000	363.000
70	Resusitator (Ambubag, Mayo)	80.000	80.000
71	Skin Test	30.000	30.000
72	Skiren	10.000	10.000
73	Sonde	10.000	10.000
74	Spirometri	470.000	470.000
75	Suction	70.000	70.000
76	Suction Pump	100.000	100.000
77	Surat sehat	60.000	60.000
78	Syringe Pump per 24 jam	110.000	110.000
79	Tindakan ETT	730.000	730.000
80	Tindakan Intubasi	730.000	730.000
81	Tindakan Intubasi Isolasi	1.530.000	1.530.000
82	Tlood PAB	180.000	180.000
83	Tredmill Stress Test	316.750	316.750
84	Ultrasound	330.000	330.000
85	Uroflometri	620.000	620.000
86	Vena Seksi Umbilikal	1.020.000	1.020.000

9. TARIF OPERATIF

A. OPERASI KECIL BPJS KETENAGAKERJAAN		
NO	Komponen	Operasi Kecil
		I,II,III
1	Sewa OK	1,135,339
2	Sewa Alat OK	1,000,000
3	Jasa Dokter Bedah	1,272,321
4	Dokter Anastesi	424,107
5	Asisten Bedah	127,232
6	Asistem Anastesi	100,000
7	Instrumen	100,000
8	Onloap	100,000
	Total	4,259,000

B. OPERASI SEDANG BPJS KETENAGAKERJAAN		
NO	Komponen	Operasi Sedang
		I,II,III
1	Sewa OK	1,999,829
2	Sewa Alat OK	1,500,000
3	Jasa Dokter Bedah	3,485,003
4	Dokter Anastesi	1,161,668
5	Asisten Bedah	348,500
6	Asistem Anastesi	100,000
7	Instrumen	100,000
8	Onloap	100,000
	Total	8,795,000

C. OPERASI BESAR BPJS KETENAGAKERJAAN		
NO	Komponen	Operasi Besar
		I,II,III
1	Sewa OK	2,387,172
2	Sewa Alat OK	1,750,000
3	Jasa Dokter Bedah	6,000,000
4	Dokter Anastesi	2,000,000
5	Asisten Bedah	573,266
6	Asistem Anastesi	191,089
7	Instrumen	144,727
8	Onloap	96,484
	Total	13,142,738

D. OPERASI KHUSUS BPJS KETENAGAKERJAAN		
NO	Komponen	Operasi Khusus
		I,II,III
1	Sewa OK	4,135,916
2	Sewa Alat OK	2,000,000
3	Jasa Dokter Bedah	6,835,938
4	Dokter Anastesi	2,278,646
5	Asisten Bedah	683,594
6	Asistem Anastesi	227,865
7	Instrumen	180,908
8	Onloop	120,605
	Total	16,463,472

Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan standar. Besar biaya transportasi sesuai ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2019 yaitu transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan transportasi udara paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

II. **Tarif Pelayanan medis operatif/Tindakan operatif kondisi tertentu bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja/PAK**

Perhitungan tarif pada pelayanan medis operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut:

- a. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif secara bersamaan pada pasien yang sama, dengan operator lebih dari satu orang (bukan kasus fragmentasi), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a.1 Tindakan Operatif Utama:
Operator pertama yang melakukan tindakan operatif utama dikenakan tarif 100% sesuai dengan paket tindakan operatif atau tarif yang berlaku. Ini merupakan tindakan yang paling kompleks atau penting yang dilakukan selama prosedur.
 - a.2 Operator Kedua (atau Lebih):
Jika ada operator lain yang melakukan tindakan operatif tambahan secara bersamaan pada pasien yang sama, operator kedua juga dihitung sebesar 100% atau sesuai tarif yang berlaku.
 - a.3 Tindakan Anestesi:
Untuk tindakan anestesi, jasa pelayanan anestesi dihitung maksimal sebesar 40% dari tarif jasa pelayanan operator yang terlibat dalam tindakan operatif tersebut.
- b. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif (bukan kasus fragmentasi) yang dilakukan oleh satu operator dalam waktu bersamaan pada pasien yang sama, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - b.1 Tindakan Operatif Utama:
Tindakan operatif utama dihitung sebesar 100% (seratus persen) dari tarif atau sesuai dengan tarif paket tindakan operatif yang berlaku. Tindakan ini adalah prosedur yang dianggap paling kompleks atau utama yang dilakukan selama operasi.

- b.2 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi tubuh yang sama:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif tindakan tersebut.
- b.3 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi tubuh yang berbeda:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif tindakan tersebut.
- c. Tindakan medis reoperasi adalah tindakan operasi ulang untuk melakukan revisi atas tindakan operasi pertama dan dilakukan masih dalam *masa perawatan, maka diatur:
 - c.1 Reoperasi ke-1 (kesatu) diberikan sebesar maksimal 75% (tujuh puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif;
 - c.2 Reoperasi ke-2 (kedua) dan ketiga, 50% (lima puluh persen) dari jasa; dan
 - c.3 Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.

*masa perawatan adalah periode dimana pasien berada dalam masa rawat inap.
- d. Tindakan medis operatif yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa pelayanan operator.

III. Penggolongan Tindakan Operasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja/PAK

- 1. Operasi *cito* adalah tindakan bedah yang harus segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien untuk mendapatkan hasil optimal bagi keselamatan pasien, dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) jam sejak pasien di asesmen oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).
- 2. Tarif Tindakan *cito* adalah sebesar biaya operasi terencana.
- 3. Setiap tindakan operatif melampirkan salinan hasil laporan operasi yang minimal memuat :
 - 3.1. jenis dan tindakan operatif;
 - 3.2. diagnosa penyakit;
 - 3.3. tanggal dan waktu tindakan operatif;
 - 3.4. jumlah dan nama dokter yang melakukan operatif;
 - 3.5. ringkasan tindakan operatif; dan
 - 3.6. kesulitan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan operatif.
- 4. Daftar pengelompokan tindakan operatif orthopedi sebagai berikut:

PENGGOLONGAN TINDAKAN OPERATIF ORTHOPEDI

I. KNEE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed Reduction knee
3	BESAR I	Open Reduction knee
4	BESAR III	ORIF
5	KHUSUS I	1. ORIF Advance 2. Arthroscopy Diagnostic 3. Open knee debridement 4. Arthroscopy debridement knee 5. Arthroscopy remove loose body 6. Arthroscopy Meniscectomy 7. Arthroscopy Synevectomy knee
6	KHUSUS II	1. Arthroscopy meniscus repair 2. Microfracture 3. Single ligament reconstruction of the knee 4. Primary total Knee Replacement 5. Autogenous Chondrocyte Implantation 6. Osteotomy around the knee (HTO/DFO)
7	KHUSUS III	1. I Revisi TKR 2. Difficulty primary total knee replacement 3. Multiligament reconstruction of the knee 4. Ligament reconstruction + meniscus/cartilage repair

II. SPINE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT - TINDAKAN
1	SEDANG II	1. Mayor degloving, wound debridement and repair of the spine 2. Plaster application of extremity & spine 3. Traction application of the spine
2	SEDANG III	1. Biopsy Vertebra (1 level) 2. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia. 3. Body cast / Halo vest / Minerva application
3	BESAR I	1. Discograph (1 level)
4	BESAR II	1. Removal of Implants (plate, nail, screw) 2. Discograph (Mult ilevel)
5	BESAR III	1. IDET 1(1 level) 2. Open Disectomy (1 level) 3. Thermal Disc 4. Facet Block

		- Radiofrequency - CESI - Foraminal Block / Selective nerve root block - Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD)
6	KHUSUS I	- Debridement in spinal infection without stabilization - Open reduction of spinal fracture/dislocation without stabilization - Posterolateral fusion / alar transverse fusion - Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (1 level) - Microscopic Decompression (1 level) - Laminectomy (1 level) in simple spine stenosis - Open disectomy multilevel - IDET multilevel - Vertebroplasty - Kyphoplasty - Acromial dc score level - ACCF / ACDF single level - Open door laminoplasty without instrumentation - Exploration and Repair of Nerve and/or spinal cord injury
7	KHUSUS II	- Debridement spinal infection + anterior/posterior stabilization - Open reduction of spinal fracture + stabilization - Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization - Anterior disectomy for correction of scoliosis - Open door laminoplasty + instrumentation - Microscopic Decompression (Multi level) - Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (Multi level) - Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) - Total Disc Replacement (1 level) - Anterior decompression thoracic + thoracotomy - Decompression dengan score > 2 level - ACCF / ACDF (Multi level) - Thoracoscopy
8	KHUSUS III	- Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation - Debridement in infection case of the spine +

		anterior and posterior stabilization 3. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord with instrumentation/stabilization 4. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis 5. Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) + anterior/posterior stabilization 6. Total Disc Replacement (Multi level) 7. Deformity correction 8. Decompression + miss dengan score
--	--	---

III. TRAUMA

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	1. Tindakan dilakukan dengan anestesi local 2. External Fixation Wire/Schanz Pin (Only) Revision and/or Removal 3. Screw (only) removal/Revision (i.e syndesmotic screw, removal of interlocking screw for dynamization) 4. Secondary /Delayed Primary Suturing of wounds
2	SEDANG	1. Debridement of Wound (without Fracture) 2. Removal of External Fixation (without Conversion to other fixation) 3. Antibiotic Bone Spacer/Beads Insertion or Exchange (without fixation / revision of fixation) 4. Bone Graft insertion (without fixation or revision of fixation) 5. Skin graft (Full or Split Thickness) 6. Manipulation of Joints Under Anesthesia 7. Fasciotomy for Compartment syndrome or other diagnosis (without fixation) 8. Local Skin Flap for wound closure (without fracture)
3	BESAR	1. Fixation of Simple Extraarticular Fracture (internal fixation, external fixation) 2. Closed Reduction +/- Circular Cast / Splint 3. Temporary Fixation by external fixation (for Damage Control Orthopedics/Part of Staged Fixation) 4. Debridement of Open Fracture +/- temporary external fixation 5. Debridement of Osteomyelitis/Infected Fracture (without Fixation / revision of fixation) 6. Amputation (primary / revision) 7. Arthrodesis 8. Removal of Hardware

		9. Joint contracture release
4	KHUSUS I	1. Fixation of Multiple Extraarticular Fracture 2. Fixation of Complex Extraarticular Fracture (Proximal Femur, Comminuted diaphyseal, Bone Loss, Neglected, etc) 3. Intraarticular/Periarticular Fracture Fixation (other than Acetabular Fracture) 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Extrarticular Fracture 5. Flap (Pedicled/Regional for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure) 6. Corrective Osteotomy 7. Debridement of Osteomyelitis/Fracture Related Infection (with Fixation/Revision of Fixation) 8. Osseointegration procedure for Amputation 9. Distraction Arthroplasty 10. Limb Lengthening 11. Conversion to Internal Fixation after Bone Lengthening/Transport
5	KHUSUS II	1. Fixation of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Fixation of Intraarticular Fracture with Ligament Repair or Reconstruction 3. Fixation of Multiple Intraarticular Fracture 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Intraarticular Fracture 5. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Regional Flap and/or Skin Graft) 6. Critical-Sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, Masquelet, Vascularized Bone Graft.) without soft tissue procedure 7. Flap (Free-Flap) for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure)

6	KHUSUS III	1. Revision of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Critical-sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, masquetelet, Vascularized Bone Graft, etc) with Soft Tissue Procedure (Flap, Tendon Lengthening, Release, etc) 3. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Free Flap) 4. Joint Replacement (for Intraarticular Fracture, Periarticular Nonunion/Malunions, and/or Muskuloskeletal Infection) 5. Megaprosthesis/Endoprosthesis (for Severe Fracture, periarticular bone defects and/or Muskuloskeletal Infection)
---	------------	--

IV. HAND

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	1. Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional 2. Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision 3. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 4. Nail bed, laceration, repair (single)
3	BESAR I	1. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single) 2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single) , drainage 3. Jari, injury, degridement 4. Jari, Superficial infection, drainage 5. Jari, wart /corn/naevus, excision 6. Jari, various, amputasi (single) 7. Jari, deep infection, drainage 8. Jari, crush injury (simple), wound debridement 9. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis excision 10. Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release
4	BESAR II	1. Jari, scar, revision Osteotomy 2. Jari /Digit, Stump, revision 3. Nail Bed, laceration, repair (multiple) 4. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle 5. Jari, Jaringan lunak tumor, excision 6. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi

		7. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage 8. endon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage 9. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna 10. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
5	BESAR III	1. Tendon (Ekstremitas atas) contracture , tenotomy 2. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair 3. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis
6	KHUSUS I	1. Nerve, Various lesions, biopsy 2. Kulit dan jaringan subkutis , Defect (Single digit) , Free full thicckness graft 3. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single) 4. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 5. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 6. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral) 7. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral), release 8. Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release 9. Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi 10. Jari, trauma, terminalisation (single) 11. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single) 12. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage 13. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi 14. Jari, ring constriction (single), koreksi 15. Jari, trauma, terminalisation (single) 16. Jari, Deformities, osteotomy 17. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft 18. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple) 19. Nerve (Ekstremitas atas) , carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) 20. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral) 21. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis 22. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release bilateral with endoneurolysis) 23. Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's

		(Bilateral), release 24. Thumb, deformities, koreksi 25. Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle 26. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi 27. Jari, ring constriction (multiple), koreksi 28. Jari, Syndactyly (multiple) 29. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 30. Tendon – flexor (ekstremitas atas) , Defect grafting (single)
6	KHUSUS II	1. Nerve digital, injury, Microsurgical (single) 2. Nerve ulnar, entrapment, transposition 3. Elbow , tennis elbow, release 4. Elbow (Medial epicondyle) , fracture , excision bony fragment 5. Jari, various lesions, amputasi (multiple) 6. Artery, large, Injury, repair with grafting 7. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis 8. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple) 9. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single) 10. Thumb, paralysis, opponens plasty 11. Jari, deformity, instrinsic muscle release / transfer / extensor relocation 12. Jari, deformities, major reconsructive procedure 13. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) 14. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation 15. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
7	KHUSUS III	1. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division) 2. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division) 3. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (division) 4. Nerve defect, peripheral graft 5. Nerve various lesions, primary / secondary suture 6. Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi 7. Jari, deformities, Koreksi 8. Jari, Syndactyly (single) Koreksi 9. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi 10. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy 11. Nerve digital, injury, primary repair

		12. Jari, Macroductyly, debulking
--	--	-----------------------------------

v. H I P

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed reduction hip
3	BESAR I	Open reduction hip
4	BESAR II	ORIF
5	BESAR III	1. Hip arthroscopy diagnostic 2. Debridement
6	KHUSUS I	1. Advance ORIF 2. Simple Arthroscopy HiD 3. Hip Arthroscopy CAM Osteoplasty 4. Pincer resection 5. Subimpingement Resection 6. Gluteus tendon repair / snapping hip 7. Hamstring repair/reconstruction
7	KHUSUS II	1. Hemiarthoplasty 2. Advance Arthroscopy Hip 3. Primary Total Hip Replacement (THR) 4. ORIF with minimal invasive 5. Core decompression 6. Osteotomy around the hip 7. Single ligament reconstruction of the hip 8. Hip arthroscopy labral repair 9. Varus/ valgus derotational osteotomy
8	KHUSUS III	1. Revisi THR 2. Difficulty Primary total hip replacement 3. Multiligament reconstruction of the hip 4. Hip arthroscopy labral reconstruction 5. Ligamentum teres reconstruction 6. Periacetbular osteotomy 7. Arthroplasty Jari 8. Arthroscopy 9. Tendon Transfer 10.FFMT

vi. SPORT INJURY

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
----	-------------------	--------------------------

1	KHUSUS I	1. Diagnostic: Arthroscopic (Knee) 2. Debridement: Arthroscopic (Knee) 3. Cartilage Defect Treatment 4. Microfracture : Arthroscopic 5. Lateral Release (combine) : Knee Arthroscopic and open surgery 6. Knee Arthrofibrosis release 7. Diagnostic : Arthroscopic (Ankle) 8. Debridement: Arthroscopic (Ankle) 9. Ankle Peroneal Tendon Repair 10. Management of Plantar Fasciitis (Arthroscopic) 11. Cartilage Problem in Ankle Treatment 12. Calcified Tendinosis Removal (Shoulder) 13. Management of Elbow Tendinosis 14. Tennis Elbow Release 15. Loose Body Removal: Arthroscopic (Elbow) 16. Diagnostic: Arthroscopic (Hip) 17. Debridement: Arthroscopic (Hip)
2	KHUSUS II	1. Colletral Ligament Reconstruction (Knee) 2. Meniscus Repair : Arthroscopic 3. Discoid Menicus Treatment 4. Arthroscopic Assisted Internal Fixation (Knee) 5. Postero Lateral Corner Reconstruction 6. Management of Ankle Impingement: Arthroscopic 7. Sinus Tarsi Syndrome 8. Management of Achilles Problem 9. Management of Impingement Syndrome (Shoulder) 10. Open Rotator Cuff Repair 11. Repair Rotator Cuff Tears (Mini Open) 12. Biceps Tendon Repair and Tenodesis 13. Frozen Shoulder Treatment 14. Anterior – Inferior Instability : Open Repair 15. Adhesive Capsulitis Relase (Shoulder) 16. Arcomioclavicular Joint Treatment 17. Elbow Contracture Release: Arthroscopic 18. Wrist Sports Injury 19. TFCC Injury 20. Loose Body Removal: Arthroscopic (Hip) 21. Femoral Acetabular Impingement Management: Arthroscopic 22. Hip Extraarticular Management
3	KHUSUS III	1. ACL Reconstruction (single or double Bundle) : Arthroscopic 2. ACL Reconstruction Adolescence: Arthroscopic 3. PCL Reconstruction: Arthroscopic 4. Multi Ligament Reconstruction (Knee) 5. Revision of Ligament Reconstruction (Knee) 6. Meniscus Transplant

		7. MPFL Reconstruction (combine): Arthroscopic and open surgery 8. Chondrocyte Replantation: Arthroscopic (Knee) 9. Patella Instability Treatment 10. Sports related Osteotomy (Knee) 11. Management of Ankle Instability 12. Shoulder Instability Treatment 13. Arthroscopic Rotator Cuff Repair 14. Management of Irreparable Rotator Cuff Tears 15. Superior Labrum Anterior Posterior Lesion Repair (Shoulder) 16. Shoulder Anterior and Anteroinferior Instability : Arthroscopic Repair 17. Shoulder Posterior Instability Treatment 18. Shoulder Multi-Directional Instability Treatment 19. Management of Elbow Instability 20. Labrum Repair: Arthroscopic
--	--	--

VII. FOOT AND ANKLE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG	1. Injeksi intraarticular / intralesi tanpa guiding 2. Closed reduction untuk dislokasi sendi
3	BESAR I	1. Debridement terbuka 2. Release hammer toe (single) 3. Biopsi eksisi 4. Injeksi intraarticular dengan image guiding 5. Implant removal (simple) 6. Amputasi toes / disartikulasi IP, MTP joint 7. Ostectomy 8. Morton neuroma decompression / excision
4	BESAR II	1. Implant removal (dengan penyulit) 2. Arthrotomy debridement 3. Release tarsal tunnel 4. Release hemmer toe (multiple) 5. Amputasi ray, midfoot, hindfoot, ankle 6. Closed reduction + internal fixation 7. ORIF / CRIF fraktur forefoot 8. Tendon lengthening 9. Plantar fasciotomy 10. Syndesmosis fixation

5	KHUSUS I	1. Open repair Achilles tendon 2. Gastrocnemius recession 3. Osteotomy calcaneus 4. Arthroscopy diagnostik 5. Arthroscopy removal loose bodies 6. Tendon repair 7. Percutaneous pinning pada foot/ankle joint 8. Calcaneoplasty untuk Achilles tendinopathy 9. Open reduction untuk dislokasi sendi 10. ORIF fraktur ankle malleolus / bimalleolar 11. Cheilectomy 12. Peroneal retinaculum repair 13. Midfoot reconstruction (termasuk Lisfranc joint) 14. Release Baxter nerve entrapment
6	KHUSUS II	1. Arthroscopy foot/ankle capsular release 2. Percutaneous repair Achilles tendon 3. Hallux valgus reconstruction 4. Arthroereisis 5. Foot/ankle joint arthrodesis 6. ORIF intraarticular ankle joint dengan LCP 7. Single stage deformity correction 8. Achilles tendon reconstruction 9. Tendon transfer 10. Arthroscopic treatment for ankle impingement 11. Open ligament repair / reconstruction 12. ORIF fraktur midfoot, hindfoot 13. ORIF fraktur trimalleolar 14. Open technique for osteochondral lesion treatment 15. Plantar plate repair 16. Peroneal groove deepening 17. Weil osteotomy 18. Arthroscopy hindfoot, subtalar, forefoot 19. Endoscopy tendon, tendon sheath, sinus tarsi
7	KHUSUS III	1. Total ankle replacement 2. Revisi total ankle replacement 3. Supramalleolar osteotomy 4. Hallux valgus reconstruction dengan prosedur tambahan 5. Gradual deformity correction dengan Ilizarov technique 6. Distraction arthroplasty / arthrodesis dengan Ilizarov technique 7. Arthroscopy assisted internal fixation (ARIF) foot/ankle joint 8. Arthroscopy haglund resection 9. Arthroscopic ligament reconstruction / tendon transfer 10. Arthroscopic treatment for osteochondral lesion 11. Arthrodesis multiple joints

VIII. SHOULDER AND ELBOW

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2	SEDANG	Biopsy shoulder/ elbow joint
3	BESAR I	Debridement shoulder / elbow joint
4	BESAR II	1. Percutaneous release ECRB 2. Hydrodilatation frozen shoulder
5	KHUSUS I	1. Open acromioplasty 2. ORIF Proximal humerus Neer 2 part 3. Ulnar nerve decompression +/- transposition 4. Ulnar nerve decompression +/- transposition
6	KHUSUS II	1. Suprascapular nerve block for adhesive capsulitis 2. Debridement for septic arthritis / osteomyelitis and prosthetic joint infection around shoulder and elbow joint 3. Open rotator cuff repair (<= 1 tendon) 4. ORIF proximal humerus Neer 3 part with bonegraft and PHILOS 5. ORIF distal humerus double column without olecranon osteotomy 6. Complex radial head fracture (ORIF/ resection) 7. Arthroscopic diagnostic shoulder/ elbow 8. Arthroscopic synovectomy/ remove loose body shoulder/ elbow 9. early repair of serratus anterior avulsion 10. Neurolysis of long thoracic nerve
7	KHUSUS III	1. Transtendineous rotator cuff repair 2. Single row arthroscopic rotator cuff repair 3. Transosseus equivalent/ suture bridge repair of rotator cuff- arthroscopy 4. Margin convergence repair in large massive rotator cuff repair 5. Muscle sliding repair in retracted rotator cuff repair 6. Superior capsular reconstruction fascia lata for massive cuff tear 7. LHB capsular reconstruction for massive cuff tear 8. Arthroscopy rotator cuff repair with augmentation 9. Arthroscopic subacromial decompression 10. Arthroscopic subcoracoid decompression 11. Arthroscopy biceps tenodesis/ tenotomy 12. Mini open subpectoral tenodesis 13. Arthroscopy rotator interval release 14. Arthroscopy 360 degree capsular release in adhesive capsulitis 15. Latissimus dorsi transfer for posterior superior cuff

		deficiency 16. Lower trapezius transfer for external rotation deficit of shoulder 17. Pectoralis major transfer for anterior superior cuff deficiency 18. Reverse shoulder arthroplasty for massive rotator cuff tear 19. Graft reconstruction for late pectoralis major rupture 20. Pectoralis major transfer for late deltoid rupture 21. Arthroscopic decompression for snapping scapula syndrome 22. Muscle transfer for scapular winging 23. Scapulothoracic fusion 24. AC Joint ligament reconstruction open / arthroscopy 25. Pectoralis major repair/ reconstruction for pectoralis major rupture 26. Latissimus dorsi repair/ reconstruction for latissimus dorsi rupture 27. Eden Hybinete for anterior recurrent shoulder dislocation 28. Glenoid bone reconstruction for anterior recurrent shoulder dislocation (open/ arthroscopy) 29. Arthroscopy capsulolabral repair for shoulder instability 30. Arthroscopic bony bankart repair 31. Arthroscopic posterior labral repair 32. Arthroscopic SLAP repair 33. Arthroscopy capsular plication for multidirectional instability 34. Arthroscopic remplissage for hillsach lesion 35. Reverse Mclaughlin/ iliac crest bone graft to humeral head for posterior recurrent shoulder dislocation (open/arthroscopy) 36. Complex fracture of acromion 37. Complex fracture of scapular (open)/ revision 38. Complex fracture of proximal humerus 39. Hemiarthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 40. Total/Reverse shoulder arthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 41. Arthroscopic ECRB release for lateral epicondylitis 42. Medial collateral ligament reconstruction of elbow 43. Lateral collateral ligament reconstruction of elbow 44. Triceps tendon repair/reconstruction 45. Distal biceps tendon repair, button/ anchor, single/double incision 46. Ancones interposition arthroplasty for lateral
--	--	--

		compartment OA 47. Reconstruction elbow for stiff elbow and unreduced dislocation 48. Arthroscopy release lateral / medial epicondylitis Arthroscopic assisted for intraarticular fracture of elbow 49. Terrible triad of elbow 50. Complex intra articular distal humeral fracture with olecranon osteotomy 51. Radial head arthroplasty for complex radial head fracture 52. Total elbow arthroplasty for complex fracture 53. Elbow interpositional arthroplasty 54. Arthrosopic of osteochondritis dissecans of elbow
--	--	--

IV. Tarif pelayanan/perawatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja/dugaan PAK

Tarif pelayanan/perawatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja/dugaan PAK adalah menggunakan tarif INA-CBGs sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Berita Acara Negosiasi

Berita Acara Negosiasi ini digunakan untuk negosiasi ketentuan tarif sebelum dilakukan perjanjian kerja sama atau adendum Perjanjian Kerja Sama. Bentuk Berita Acara Negosiasi Tarif Kerja Sama adalah sebagai berikut:

**BERITA ACARA
NEGOSIASI TARIF KERJA SAMA**

Pada hari ini, Kamis tanggal 04 bulan Desember tahun 2025 (04/12/2025) pukul 14.00 WIB, antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan dengan RS Prima Husada Sukorejo telah diadakan negosiasi harga Tarif Kerja Sama tahun 2026 sesuai penawaran terlampir :

Hasil negosiasi tersebut diatas disetujui RS Prima Husada Sukorejo dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan serta ditandatangani oleh yang berhak dan mewakili dibawah ini.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rs Prima Husada Sukorejo	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan
(Ns. Heni Indra Wulandari, S.Kep., M.Kep) (Direktur Rumah Sakit)	(Sulistijo Nisita Wirjawan) (Kepala Kantor Cabang)

SAKSI

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. nama : (saksi PIHAK PERTAMA)
jabatan | |
| 2. Anita Fitriasari, SE
Keuangan RS | : (saksi PIHAK KEDUA) |

**PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

**PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN**

**Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT**

**SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG**

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor **PIHAK PERTAMA**)
Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

I. Tata Cara Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

1. Dokumen kelengkapan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Peserta;
 - b. KTP atau Passport bagi Warga Negara Asing;
 - c. surat pengajuan tagihan pembayaran yang ditandatangani oleh pimpinan **PIHAK KEDUA** atau Pihak dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan kewenangan beserta rincian tagihan biaya Pelayanan Kesehatan;
 - d. SKP;
 - e. kuitansi bermeterai cukup atau kuitansi digital elektronik;
 - f. bukti pembayaran iuran terakhir bulan berjalan **PIHAK KEDUA** atas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - g. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
2. Dalam hal Peserta telah disimpulkan Kecelakaan Kerja oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau PAK oleh dokter yang merawat/memeriksa dari **PIHAK KEDUA**, tagihan biaya Pelayanan Kesehatan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
 - a. Biaya Pelayanan Kesehatan sebelum Kesimpulan KK/PAK menggunakan tarif INA CBGs sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Biaya Pelayanan Kesehatan setelah Kesimpulan KK/PAK menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam lampiran II Perjanjian Kerja Sama,
3. Dalam hal Peserta telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditambahkan surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja atau surat keterangan dokter kasus PAK (Formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus PAK);
4. Selain dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dokumen antara lain:
 - a. Hasil penunjang pelayanan medis;
 - b. Laporan tindakan medis;
 - c. resume medis Peserta;
 - d. formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) apabila disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - e. surat rujukan antar PLKK yang digunakan sebelumnya,

5. Dalam hal pengajuan tagihan dilakukan secara daring, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tetap disampaikan secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 3 (tiga) hari setelah pengajuan secara daring dari **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Dalam hal dokumen tidak lengkap, **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
9. **PIHAK PERTAMA** melakukan proses Verifikasi berkas klaim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap yang dibuktikan dengan dokumen penyampaian informasi kelengkapan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan hasil Verifikasi;
 - b. dalam hal hasil verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan;
 - c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan pada bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan pengajuan tagihan dari **PIHAK KEDUA** dengan pembayaran yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menyampaikan penyesuaian nilai pada kuitansi sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lama 3 (tiga) hari sejak pembayaran diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
11. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 10, disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA** dan kuitansi yang disampaikan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak berlaku.

II. Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan COB dengan PT. Jasa Raharja (Persero) dan asuransi lain.

1. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau dugaan Kecelakaan Kerja di lalu lintas yang memenuhi syarat dan ruang lingkup penjaminan PT. Jasa Raharja, menjadi penjamin pertama adalah PT. Jasa Raharja yang dibuktikan dengan surat jaminan Jasa Raharja.
2. Dalam hal pembiayaan layanan kesehatan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja telah memenuhi batas plafon dan/atau telah 1 (satu) tahun sejak terjadinya Kecelakaan Kerja dugaan Kecelakaan Kerja di lalu lintas, **PIHAK KEDUA** menagihkan kelebihan biaya dari plafon yang dijamin oleh PT. Jasa Raharja kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I Lampiran III ini disertai dengan bukti pembayaran manfaat oleh PT. Jasa Raharja.
3. Dalam hal kasus penjaminan dilakukan oleh asuransi lain maka selisih biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut dapat diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I Lampiran III ini ditambahkan dengan surat keterangan dari asuransi lain dimaksud yang telah melakukan penjaminan pertama.

III. Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Pembayaran dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
nomor rekening : 144-0055533324
Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang - Blimbing
4. Biaya transfer yang timbul atas pembayaran tagihan dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan surat pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan beserta bukti bayar, rincian pembayaran beserta keterangan selisih pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

IV. Rekonsiliasi Tagihan

Rekonsiliasi tagihan dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap bulan untuk melakukan pencocokan data, transaksi dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan dokumen dan data yang ada pada **PARA PIHAK** agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan di masing-masing Pihak dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut:

**BERITA ACARA
REKONSILIASI TAGIHAN
NOMOR : BA/.../...**

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekonsiliasi klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas, periode bulan sd, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

[illegible]

Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Pusekesmas

(nama kepala kantor cabang)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Jabatan :

Jabatan :

V. Dokumen Penyampaian Informasi Kelengkapan dokumen Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

INFORMASI KELENGKAPAN DOKUMEN TAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : .../.../...

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, Puskesmas, mengajukan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang, untuk klaim bulan pelayanan, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus Pengajuan**	Dokumen Lengkap (Kasus)	Dokumen tidak Lengkap (Kasus)	Keterangan
UGD				
Rawat Jalan				
Rawat Inap				
Perawatan lainnya				
Jumlah				

Dokumen lengkap akan dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang tidak lengkapkasus, untuk dapat dilengkapi paling lambathari.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Puskesmas

(nama kepala kantor cabang)

(.....)

Jabatan:

Jabatan:

** detil nama pasien terlampir

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN

Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT

SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

BENTUK PAKTA INTEGRITAS PLKK

PAKTA INTEGRITAS
(Nama PLKK)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

NO	NAMA	NIK	NO.TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT
1	Ns. Heni Indra Wulandari, S.Kep., M.Kep	3507256407860003	0813 1557 4065	backupdatamarketingphs@gmail.com	02/01/2024	24/07/2026

2. Petugas penanggungjawab pada Aplikasi e-PLKK sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO.TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT
1	Prisna Sandy Faradilla, S.ST	3572014903960001	082142036398	keuanganrshs@gmail.com	01/01/2025	31/12/2027

3. Petugas penanggungjawab administrasi sebagai narahubung BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO.TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT
1	Prisna Sandy Faradilla, S.ST	3572014903960001	082142036398	keuanganrshs@gmail.com	01/01/2025	31/12/2027

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Dalam menggunakan *user login* untuk melakukan entri data pada Aplikasi e-PLKK akan menjaga kerahasiaan dan tidak memiliki niat dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan diatas.
- b. Dalam waktu 1x24 jam akan melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat pergantian petugas entri baik dikarenakan pindah tugas maupun adanya putus hubungan kerja.
- c. Berkomitmen untuk melakukan pekerjaan secara profesional atas dasar kejujuran dan bertanggung-jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah disepakati dengan BPJS Ketenagakerjaan
- d. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- e. Berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
- f. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini. Demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara hukum apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini kami tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 04 Desember 2025

KEPALA/PIMPINAN/DIREKTUR	PENANGGUNGJAWAB USER	PENANGGUNGJAWAB NARAHUBUNG
<u>Ns. HENI INDRA WULANDARI,</u> <u>S.Kep., M.Kep</u> DIREKTUR RUMAH SAKIT	<u>Prisna Sandy Faradilla, S.</u> <u>ST</u> PELAKSANA	<u>Prisna Sandy Faradilla, S.</u> <u>ST</u> PELAKSANA

*) TMT: Terhitung Masuk Tanggal
*) TAT: Terhitung Akhir Tanggal

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN

Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT

SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN V
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: 2111/RSPHS/E-PKS/DIR/XII/2025

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

PIHAK PERTAMA BPJS Ketenagakerjaan Alamat Kantor Alamat web : www.bpjsketenagakerjaan. go.id Nomor Telp/faks Petugas yang dapat dihubungi (PIC) Jabatan..... No HP : Alamat email :	PIHAK KEDUA Alamat Kantor Jl. Raya Surabaya - Malang, KM 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Alamat web : https://rs-primahusada.com/rsph-sukorejo/ Nomor Telp/faks (0343) 6745 000 Petugas yang dapat dihubungi (PIC) 1. PIC Administrasi Prisna Sandy Faradilla, S. ST Jabatan Pelaksana No HP 0821 4203 6398 Alamat email keuanganrsphs@gmail.com	2. PIC Klinis Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medik No HP 0813 1557 4065 Alamat email backupdatamarketingsphs@gmail.com
---	---	--

PIHAK KEDUA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN

Ns. HENI INDRA WULANDARI, S.Kep., M.Kep
DIREKTUR RUMAH SAKIT

SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG